

FICHA TÉCNICA MONOGRÁFICA DE EVALUACIÓN CLÍNICA

ESCALA DE CATASTROFIZACIÓN ANTE EL DOLOR (PCS)

Pain Catastrophizing Scale (Sullivan, Bishop & Pivik, 1995) · Validación Española (García-Campayo et al., 2008)

1. IDENTIFICACIÓN GENERAL Y FICHA RESUMEN

Nombre oficial	Escala de Catastrofización ante el Dolor (Pain Catastrophizing Scale, PCS)
Sigla / Acrónimo	PCS
Autoría original	Michael J. L. Sullivan, Scott R. Bishop & Joyce Pivik (McGill University, Canadá, 1995)
Adaptación en español	Javier García-Campayo et al. (2008, Med Clin); Olmedilla et al. (2013)
Constructo evaluado	Mecanismos cognitivos disfuncionales y pensamientos catastróficos asociados a la vivencia dolorosa
Población diana	Adultos con dolor crónico (fibromialgia, lumbalgia, artritis), deportistas lesionados o dolor agudo
Tiempo de aplicación	3 a 5 minutos (autoadministrado)
Estructura y formato	13 ítems puntuados en escala tipo Likert de 5 puntos (0 = nada en absoluto, 4 = todo el tiempo)
Condiciones de uso	Propiedad intelectual distribuida bajo licencia de Mapi Research Trust / ePROVIDE

2. FUNDAMENTACIÓN CONCEPTUAL Y MODELO TEÓRICO

La catastrofización del dolor se define conceptualmente como un conjunto de respuestas cognitivas y afectivas negativas exageradas ante estímulos dolorosos reales o anticipados. De acuerdo con el influyente **Modelo de Miedo-Evitación del Dolor** (Vlaeyen & Linton), ante una lesión nociceptiva, las personas que interpretan el dolor a través de pensamientos catastróficos desarrollan hipervigilancia corporal y conductas de miedo al movimiento (kinesiofobia). Esto genera desacondicionamiento muscular, depresión reactiva y mayor discapacidad.

Sullivan y colaboradores estructuraron la catastrofización en tres procesos complementarios: 1) **Rumiación** (focalización atencional excesiva e incapacidad para desviar el pensamiento del dolor); 2) **Magnificación** (sobreestimación de la gravedad y anticipación de consecuencias destructivas); y 3) **Indefensión** (sensación de falta absoluta de recursos de afrontamiento y control personal). El PCS es el predictor psicológico más potente de la cronificación del dolor, del consumo de opioides y de la falta de respuesta a cirugías de columna.

3. ESTRUCTURA FACTORIAL Y COMPOSICIÓN DE SUBESCALAS

Subescala	Ítems Origen	Rango	Definición Operativa y Foco Cognitivo
Rumiación	Ítems 8, 9, 10, 11	0 - 16	Monopolización atencional constante ("No puedo dejar de pensar en lo mucho que me duele")
Magnificación	Ítems 6, 7, 13	0 - 12	Sobredimensión de la amenaza nociceptiva ("Temo que algo terrible me vaya a ocurrir")
Indefensión	Ítems 1, 2, 3, 4, 5, 12	0 - 24	Percepción de impotencia y falta de eficacia ("Siento que no puedo seguir adelante así")

EVALUACIÓN PSICOMÉTRICA, BAREMACIÓN Y CÓMPUTO CLÍNICO

4. PROPIEDADES PSICOMÉTRICAS EN POBLACIÓN ESPAÑOLA Y FIBROMIALGIA

Consistencia interna	Excelente consistencia interna; alfa de Cronbach global $\alpha = 0.92$ (García-Campayo et al., 2008); subescalas: Rumiación $\alpha = 0.87$, Magnificación $\alpha = 0.79$, Indefensión $\alpha = 0.89$.
Estabilidad temporal	Fiabilidad test-retest a 6 meses con coeficiente de correlación intraclase CCI = 0.84, demostrando alta estabilidad longitudinal en ausencia de tratamiento.
Estructura factorial	Confirmación del modelo trifactorial de Sullivan mediante análisis factorial confirmatorio (RMSEA = 0.046, CFI = 0.98), con un factor general de catastrofización de segundo orden.
Validez concurrente	Correlación positiva muy alta con la Tampa Scale for Kinesiophobia (TSK, $r = 0.65$), depresión HADS ($r = 0.61$) e interferencia del dolor en BPI ($r = 0.58$).
Sensibilidad diagnóstica	Discrimina con alta precisión entre pacientes con dolor crónico adaptados vs. pacientes con baja laboral prolongada y uso crónico de opioides.

5. REGLAS DE CORRECCIÓN Y CÓMPUTO DE PUNTUACIONES

Consigna de respuesta	Se pide al paciente que indique el grado en que experimenta cada pensamiento cuando siente dolor.
Puntuación de ítems	Escala tipo Likert de 5 puntos: 0 = Nada en absoluto ; 1 = Un poco ; 2 = Moderadamente ; 3 = Mucho ; 4 = Todo el tiempo .
Puntuación total global	Suma aritmética directa de los 13 ítems. Rango teórico posible: 0 a 52 puntos . No contiene ítems invertidos.
Cálculo de subescalas	Rumiación = suma ítems 8, 9, 10, 11 (0-16); Magnificación = suma ítems 6, 7, 13 (0-12); Indefensión = suma ítems 1, 2, 3, 4, 5, 12 (0-24).

6. BAREMOS NORMATIVOS, PUNTOS DE CORTE Y ESTRATIFICACIÓN CLÍNICA

Puntuación Total	Percentil Aprox.	Estrato Clínico	Significación y Pronóstico Funcional
0 - 19 puntos	< Pc 50	Catastrofización Baja / Adaptativa	Afrontamiento cognitivo adecuado; bajo riesgo de cronificación.
20 - 29 puntos	Pc 50 - Pc 74	Catastrofización Moderada	Vulnerabilidad cognitiva intermedia; requiere monitorización activa.
30 - 52 puntos	>= Pc 75	Catastrofización Alta / Crítica	Alto riesgo de discapacidad permanente, fracaso quirúrgico y sobremedicación.

PUNTO DE CORTE CRÍTICO NORMATIVO (SULLIVAN ET AL.):

- **PCS ≥ 30 puntos (Percentil 75):** Define la catastrofización clínicamente relevante. Pacientes en este estrato tienen un riesgo cuadruplicado de persistencia del dolor a los 12 meses y de abandono laboral; se recomienda psicoterapia cognitivo-conductual o terapia de aceptación y compromiso (ACT) antes de cualquier cirugía electiva.

DECISIÓN CLÍNICA, CASO ILUSTRATIVO, SEGURIDAD Y BIBLIOGRAFÍA

7. ALGORITMO DE DECISIÓN CLÍNICA EN DOLOR PERSISTENTE

Paso 1: Medición en consulta de dolor o traumatología: Aplicar el PCS. Calcular puntuación total (0-52).

Paso 2: Si PCS < 20 (Baja): Proceder con rehabilitación física habitual y analgesia conservadora.

Paso 3: Si PCS 20 — 29 (Moderada): Integrar educación en neurobiología del dolor ("Explain Pain") para reducir la hipervigilancia.

Paso 4: Si PCS ≥ 30 (Alta):

- Suspender o posponer cirugías ortopédicas/espinales electivas hasta optimización psicológica (reducir catastrofismo antes de intervenir).
- Iniciar TCC focalizada en dolor crónico: reestructuración de pensamientos catastrofistas, exposición gradual al movimiento (desensibilización a la kinesiofobia) y técnicas de defusión cognitiva (ACT).
- Evitar la escalada agresiva de opioides potentes como respuesta única al llanto o distrés del paciente.

8. CASO CLÍNICO ILUSTRATIVO DE FIBROMIALGIA Y LUMBALGIA CRÓNICA

Identificación: Paciente mujer de 46 años, técnica de laboratorio en baja laboral de 10 meses por lumbalgia mecánica y dolor musculoesquelético difuso. Propuesta para artrodesis lumbar L4-S1.

Evaluación PCS Inicial: Puntuación Total = **42 / 52** (Percentil 95, Catastrofización Extrema).

- Desglose: Rumiación = 15/16; Magnificación = 10/12; Indefensión = 17/24. Afirma convicción de quedar en silla de ruedas ante cualquier esfuerzo físico.

Intervención: En comité multidisciplinar de columna se desaconsejó la cirugía espinal inmediata. Se derivó a programa de 10 semanas de Psicología Clínica del Dolor y Fisioterapia Activa: educación sobre sensibilización central, reestructuración cognitiva y marcha gradual asistida.

Reevaluación a los 4 meses: La puntuación total del PCS descendió a **16 / 52** (Rango bajo adaptativo, reducción de 26 puntos). La paciente reanudó paseos diarios de 5 km, abandonó el fentanilo y solicitó la reincorporación laboral a tiempo parcial sin necesidad de artrodesis.

9. ALERTAS DE SEGURIDAD CLÍNICA Y DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL

Banderas Rojas y Riesgos:

- **Fracaso Quirúrgico:** Un PCS ≥ 30 es el factor predictivo independiente más potente del síndrome de espalda fallida tras cirugía espinal.
- **Adicción y Sobredosis de Opioides:** Los pacientes catastrofizadores solicitan rescates continuos de opioides para sedar la angustia, no la nocicepción.

Diagnóstico Diferencial:

- **Catastrofización vs. Dolor Nociceptivo:** La intensidad del dolor en EVA no predice discapacidad por sí sola; el PCS predice el impacto funcional.
- **Depresión Mayor:** La indefensión del PCS se solapa con desesperanza depresiva; evaluar si hay anhedonia y síntomas melancólicos.

10. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS (FORMATO APA 7ª ED.)

- García-Campayo, J., Rodero, B., Alda, M., Sobradiel, N., Montero, J., & Moreno, S. (2008). Validación de la versión española de la escala de la catastrofización ante el dolor (Pain Catastrophizing Scale) en la fibromialgia. *Medicina Clínica*, 131(13), 487-492. <https://doi.org/10.1157/13127277>
- Sullivan, M. J. L., Bishop, S. R., & Pivik, J. (1995). The Pain Catastrophizing Scale: Development and validation. *Psychological Assessment*, 7(4), 524-532. <https://doi.org/10.1037/1040-3590.7.4.524>
- Vlaeyen, J. W., & Linton, S. J. (2000). Fear-avoidance and its consequences in chronic musculoskeletal pain: a state of the art. *Pain*, 85(3), 317-332.
- Quartana, P. J., Campbell, C. M., & Edwards, R. R. (2009). Pain catastrophizing: a critical review. *Expert Review of Neurotherapeutics*, 9(5), 745-758. <https://doi.org/10.1586/ern.09.34>